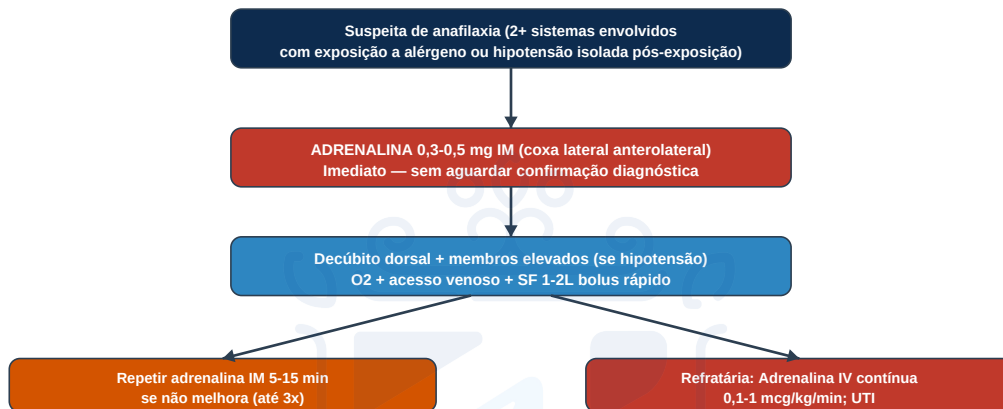


ANAFILAXIA — ADRENALINA PRIMEIRO

ALGORITMO — ANAFILAXIA

RECONHECER → ADRENALINA → SUPORTE



CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE ANAFILAXIA

Critério	Descrição
Critério 1	Início agudo com pele/mucosa (urticária, angioedema, prurido) + ao menos 1: SRA comprometida (broncospasmo, hipoxemia) OU hipotensão / colapso
Critério 2	≥2 dos seguintes após exposição a alérgeno suspeito: pele/mucosa, SRA, TGI (vômitos, dor), hipotensão
Critério 3	Hipotensão isolada após exposição a alérgeno conhecido (dose-dependente de veneno, AINE, etc.)

DROGAS — DOSES E VIAS

Droga	Dose Adulto	Via	Função
Adrenalina (1ª linha)	0,3-0,5 mg (=0,3-0,5 mL sol 1:1.000)	IM — coxa lateral	Salva a vida — broncodilatador + vasoconstritor
Adrenalina IV (refratária)	0,1-1 mcg/kg/min	IV contínuo (UTI)	Choque anafilático refratário
Difenidramina (2ª linha)	25-50 mg IV lento	IV	Antipruriginoso — NÃO substitui adrenalina
Hidrocortisona (2ª linha)	200-500 mg IV	IV	Previne reação bifásica (início tardio, não agudo)
Salbutamol inalatório	5 mg nebulização	Inalatório	Broncospasmo persistente pós-adrenalina
SF 0,9%	1-2 L IV rápido	IV	Hipotensão / choque distributivo

ERROS COMUNS — O QUE NÃO FAZER

ARMADILHAS NO TRATAMENTO

- Anti-histamínico como 1ª LINHA: anti-H1/H2 NÃO tratam broncospasmo nem hipotensão (são 2ª linha)
- Adrenalina SC (subcutânea): absorção imprevisível — via IM na coxa é padrão-ouro
- Corticoide como 1ª linha: início de ação lento (horas) — não são salvadores na fase aguda
- Manter paciente sentado/em pé se hipotensão: decúbito dorsal com pernas elevadas
- Alta precoce: monitorar 4-6h (reação bifásica ocorre em até 20%, até 72h); 24h se grave

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Simula Anafilaxia

- Choque séptico: febre, foco infeccioso, sem alérgeno
- Síncope vasovagal: bradicardia, sem urticária
- Crise asmática: sem envolvimento sistêmico
- Angioedema hereditário (C1-inh): sem urticária, sem prurido
- Síndrome carcinoide: rubor episódico sem urticária

Orientação Pós-Alta

- Prescrever caneta de adrenalina autoaplicável (EpiPen)
- Referenciar para alergologista
- Evitar alérgenos suspeitos; pulseira de alerta
- Anti-H1 VO por 3-5 dias; corticoide VO 3 dias
- Orientar sobre reação bifásica — retornar se piora

CHECKLIST — ANFILAXIA NO PS

PASSO A PASSO

- ☐ Reconhecer: 2+ sistemas ou hipotensão pós-alérgeno → NÃO aguardar confirmação
- ☐ Adrenalina 0,3-0,5 mg IM (coxa lateral) — imediatamente (1º passo, não o 3º!)
- ☐ Chamar ajuda, decúbito dorsal, O2, acesso venoso calibroso
- ☐ SF 500 mL-2L IV rápido se hipotensão
- ☐ Repetir adrenalina IM a cada 5-15 min se sem melhora
- ☐ Difenidramina IV + hidrocortisona IV como adjuvantes (2ª linha)
- ☐ Monitorar mínimo 4-6h; internação se grave, bifásica ou sem resposta

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com urticária generalizada, broncospasmo e hipotensão após ingestão de amendoim. Qual é o tratamento de PRIMEIRA LINHA?

- A) Difenidramina 50 mg IV + hidrocortisona 500 mg IV
- B) Adrenalina 0,3-0,5 mg IM na coxa lateral
- C) Salbutamol 5 mg nebulização
- D) SF 1 L IV rápido como expansão volêmica
- E) Metilprednisolona 1 g IV

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Por que a via intramuscular (coxa lateral) é preferida à subcutânea para a adrenalina na anafilaxia?

- A) A dose SC é maior e mais difícil de calcular
- B) Absorção mais rápida e previsível IM vs SC; pico sérico mais alto em menos tempo
- C) A via SC causa necrose local inevitável
- D) Não há diferença; ambas são equivalentes
- E) A via IV é contraindicada em anafilaxia leve

QUESTÃO 3

SES-RJ / Adaptada

Qual é a principal preocupação ao liberar um paciente com anafilaxia tratada no PS?

- A) Risco de reação cruzada a outros alimentos
- B) Reação bifásica: nova fase de choque/broncospasmo horas após resolução inicial
- C) Desenvolvimento de anafilaxia crônica
- D) Toxicidade tardia da adrenalina
- E) Resistência ao corticoide

QUESTÃO 4

CFM / Adaptada

Paciente com anafilaxia grave e hipotensão refratária a 3 doses de adrenalina IM e 2L de SF IV. Qual é a próxima conduta?

- A) Triplice terapia com difenidramina, hidrocortisona e ranitidina
- B) Adrenalina IV contínua 0,1-1 mcg/kg/min + UTI
- C) Noradrenalina em substituição à adrenalina
- D) Alta com prescrição de caneta autoinjetável
- E) Plasmaférese urgente

QUESTÃO 5

UFPR / Adaptada

Paciente com angioedema facial e urticária sem hipotensão nem broncospasmo, após picada de abelha. Qual diagnóstico e conduta?

- A) Anafilaxia confirmada — adrenalina IM obrigatória
- B) Reação alérgica leve (1 sistema envolvido sem risco vital) — anti-H1 + observação; adrenalina se piora
- C) Angioedema hereditário — concentrado de C1-inibidor
- D) Angioedema por IECA — adrenalina é ineficaz
- E) Urticária crônica — corticoide VO por 10 dias

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Adrenalina IM na coxa lateral é o tratamento de PRIMEIRA LINHA e salva vidas. Anti-histamínicos e corticoides são 2ª linha — início de ação lento, não resolvem broncospasmo nem hipotensão. Nunca atrasar a adrenalina.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Via IM na coxa lateral (músculo vasto lateral): absorção mais rápida, pico sérico mais alto e em menos tempo que SC. Coxa > braço IM. SC tem absorção variável e mais lenta, especialmente em choque.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Reação bifásica ocorre em 5-20% dos casos, horas após resolução inicial (mais comum em 8-12h, pode ser até 72h). Pacientes com episódio grave devem ser observados por 24h. Indicar caneta autoinjetável na alta.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Anafilaxia refratária a adrenalina IM e volume → adrenalina IV contínua (0,1-1 mcg/kg/min) na UTI. Vasopressores adicionais (noradrenalina, vasopressina) podem ser necessários como adjuvantes.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Reação alérgica: apenas urticária/angioedema sem comprometimento de SRA, cardiovascular ou TGI = 1 sistema. Não preenche critérios de anafilaxia. Anti-H1 + observação. Adrenalina se qualquer deterioração.

SM24
Suporte ao Plantão Médico